

Résistance à la protéine C activée : du dépistage individuel à l'enquête familiale



A.ABBASSENE, N.ABBASSEN, S.BOUNAAS, S.KEHILA, N.BOULEMKAHEL
Service d'hémodiologie et centre de transfusion sanguine, CHU SETIF



I-Introduction

La résistance à la protéine C activée (RPCA) constitue une anomalie biologique fréquemment associée à une thrombophilie constitutionnelle, notamment au facteur V Leiden. Sa découverte chez un sujet jeune présentant une thrombose veineuse non provoquée peut conduire à une démarche diagnostique et préventive dépassant le cadre individuel.

II-Objectif

Souligner l'intérêt de l'enquête familiale après la découverte d'une résistance à la protéine C activée (RPCA), afin d'identifier les sujets à risque thrombotique et de mettre en œuvre des mesures préventives adaptées

IV-Enquete familiale

Une enquête familiale ciblée a été réalisée.

Les apparentés de premier degré ont bénéficié d'un bilan de thrombose incluant la recherche d'une RPCA

V-Résultats

- 8 apparentés du premier degré explorés
- 6 femmes et 2 hommes
- 5 cas de RPCA identifiés
- Prévalence familiale : 62,5%
- 3 apparentés avec bilan normal

III-Cas clinique

Sujet jeune de sexe masculin ayant présenté une TVP spontanée du membre inférieur :

- Exploration de thrombophilie initialement non réalisée
- AVC sévère quelques années plus tard ayant nécessité une prise en charge en réanimation médicale
- Exploration biologique secondaire révélant une RPCA

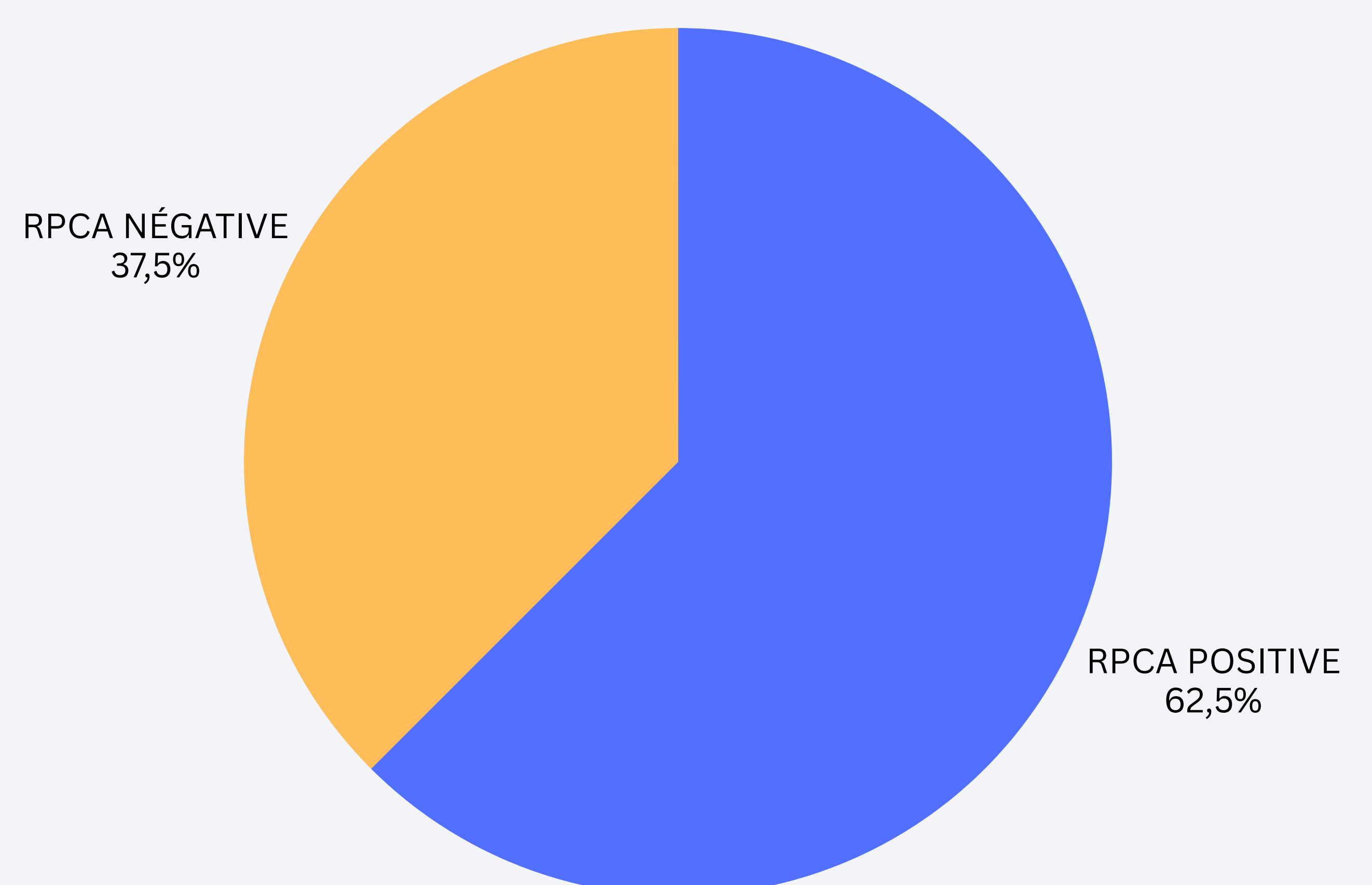


Figure 1 — Répartition de l'enquete familiale chez les apparentés du premier degré

Conclusion

La découverte d'une RPCA chez un patient ayant présenté des événements thromboemboliques a permis d'identifier plusieurs apparentés porteurs lors de l'enquête familiale. Cette démarche souligne l'intérêt du dépistage ciblé des sujets à risque à fin d'adapter les mesures préventives dans les situations thrombogènes. La recherche moléculaire de la mutation du facteur V Leiden, principale cause héréditaire de RPCA pourrait compléter l'exploration